

PATOLOGÍA DE PARED ABDOMINAL EN URGENCIAS

Haydée Calvo García, Tomás Elosua González, María Luisa De La Hoz Riesco, María Victoria Diago Santamaría, Saúl Escudero Álvarez.

INTRODUCCIÓN

Una hernia es una protrusión de parte de un órgano y/o tejido intrabdominal a través de la pared abdominal que normalmente lo contiene.

La mayoría de hernias se producen por una debilidad de la pared abdominal, una pérdida de la integridad mecánica de los músculos y fascias, necesaria para contener las vísceras por donde protruye el peritoneo parietal.

Las hernias de pared abdominal se clasifican según su etiología (congénita o adquirida), o más frecuentemente, por su localización.

Clasificación

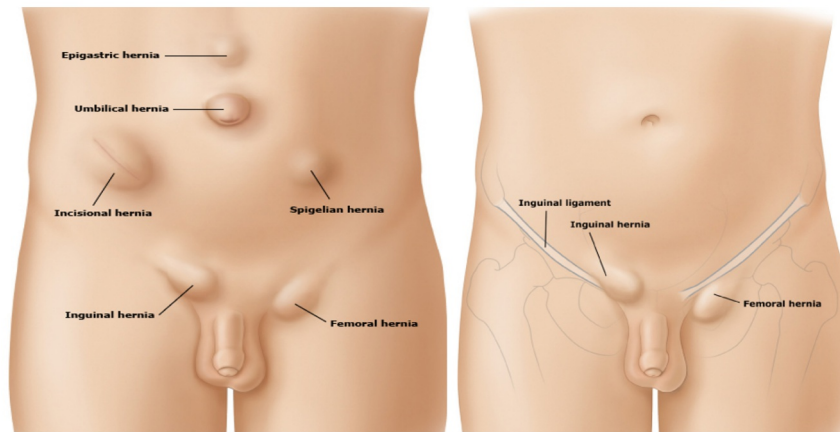
Clasificación por su localización

- **Hernia inguinal** (70-75%): por encima del ligamento inguinal. Puede ser:

Indirecta: más frecuente, en el lado derecho. Protruye por el anillo inguinal interno, por donde salen de la cavidad abdominal el cordón espermático en hombres y el ligamento redondo en mujeres. El origen del saco herniario se localiza lateral a la arteria epigástrica inferior.

Directa: protruye medial a los vasos epigástricos inferiores. Se produce por una debilidad en el suelo del canal inguinal.

- **Hernia crural** (6-17%): por debajo del ligamento inguinal, protruye a través del anillo femoral, medial a la vena femoral. Más frecuente en mujeres, sobre los 70 años, suele estrangularse.
- **Hernia umbilical** (3-14%): en región periumbilical. Más frecuente en mujeres, presentándose como masa fácilmente reductible y clínica de dolor abdominal crónico por estrangulación de grasa epiploica. En hombres suele incarcerarse.
- **Hernia epigástrica** (0.5-5%): en línea media, entre el ombligo y la apófisis xifoides. Más frecuente en varones entre 20 y 50 años. Los defectos a menudo miden 1 cm de diámetro, en un 20% de los casos son múltiples. La mayoría son asintomáticas, aunque pueden producir molestias; no suelen estrangularse, pues normalmente el saco herniario sólo contiene epiplon.
- **Hernia de Spiegel** (0.1-2%): en la línea arcuata de la vaina de los músculos rectos abdominales. La mayoría son interparietales al quedar cubiertas por la aponeurosis del oblicuo externo.
- **Hernia incisional o eventración** (12-15%): sobre cualquier incisión de cirugía previa. Ej: hernia en orificio de trócar de laparoscopia (0.65-5.2%), línea media, paramediana, subcostal, McBurney, Pfannenstiel...
- **Hernia paraestomal** (3-78%): alrededor de una ileostomía, colostomía o urostomía. La incidencia varía según el tipo de estoma y su duración. Se estima que más del 50% de los pacientes ostomizados desarrollarán una hernia paraestomal, por la debilidad de pared yatrógena inherente.



Clasificación según el compromiso que presente

- **Hernias reductibles.** Se protruyen con maniobras de Valsalva, se reintroducen en la cavidad abdominal con maniobras simples de compresión manual o con el simple decúbito supino.
- **Hernias irreductible o incarceradas.** El contenido no se reduce con facilidad, algunos casos agudos puede necesitar cirugía si no es posible reducción manual, habitualmente el anillo herniario es grande y por lo general no suele comprometer el flujo vascular.
- **Hernias estranguladas.** Presentan compromiso vascular de la víscera que contiene el saco herniario o a veces únicamente del saco herniario.

Factores de riesgo

- **Aumento de la presión intrabdominal:** obesidad, tos crónica (enfermedad pulmonar, tabaquismo...), embarazos múltiples, ascitis.
- **Debilidad de pared abdominal:** edad avanzada, cirugías previas, enfermedades crónicas (diabetes), fármacos (corticoides), collagenopatías.
- **Esfuerzo físico** intenso.
- **Sexo** masculino.
- **Enfermedad profesional** (sopladores de vidrio, músicos de viento...).

Presentación clínica

Depende de su localización y tamaño. Hernias pequeñas pueden ser asintomáticas o presentar varios grados de dolor, más intenso con maniobras de Valsalva (tos, deposición...) aunque lo más frecuente es cursar como una tumoración en la pared con o sin molestias. Hernias grandes pueden ejercer excesiva presión sobre la piel, produciendo eritema, isquemia o ulceración. Las hernias complicadas cursan con incarceración y/o estrangulación del contenido intestinal a través del defecto, lo que puede causar oclusión intestinal (náuseas, vómitos, distensión y dolor abdominal, ausencia de tránsito intestinal) e isquemia y/o perforación.

Exploración física

En bipedestación y en decúbito supino, permitiendo que el contenido herniario se reduzca y así palpar el orificio. Se debe explorar toda la pared para identificar hernias coexistentes, especialmente en cicatrices de cirugías previas y zona inguinocrural.

- **Hernia no complicada:** hernia blanda, que se reduce sin dificultad, sin signos de incarceración.
- **Hernia incarcerada:** atrapamiento del contenido herniario difícil de reducir al interior de cavidad abdominal. Cursa con aumento de inflamación local, cambio de coloración (violácea), endurecimiento y dolor.

- **Hernia estrangulada:** isquemia y necrosis del asa intestinal encarcerada



DIAGNÓSTICO

Clínico

La mayoría de hernias en pacientes delgados pueden diagnosticarse mediante anamnesis y una exploración física exhaustiva, inspección, auscultación, palpación y percusión.

Sin embargo, hernias pequeñas, en pacientes obesos o ciertos tipos de hernias (pélvicas o lumbares) requieren pruebas de imagen.

Pruebas complementarias

- Hemograma.
- Coagulación básica.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, LDH, bilirrubina, amilasa, .PCR / Procalcitonina.
- Radiografía de abdomen
- Ecografía abdominal.
- TC abdominopélvico.

En pacientes con sospecha de hernia de pared abdominal que no puede diagnosticarse mediante exploración física, el estudio más coste-efectivo a realizar es la ecografía; aunque la TC abdominopélvico es la mejor prueba para confirmar el diagnóstico e identificar el contenido del saco herniario.

Si sospecha de oclusión intestinal, solicitar radiografía simple de abdomen y analítica sanguínea completa.

Diagnóstico diferencial

- Diástasis de rectos.
- Hematoma de la vaina de los rectos.
- Seroma, granuloma de sutura o prótesis (malla, catéter diálisis...).
- Celulitis o absceso de pared.
- Lipoma.
- Endometriosis en cicatriz de cesárea.
- Anomalías del uraco.
- Neurofibromas.
- Tumores desmoides.

- Patología intrabdominal.
- Patología escrotal.

TRATAMIENTO

Tratamiento inicial en urgencias

Las hernias no complicadas deben derivarse a Consulta Externa de Cirugía General de forma preferente para valorar una reparación quirúrgica programada.

Si no son reductibles o se encuentran complicadas:

- Colocar al paciente en decúbito supino.
- Constantes vitales.
- Dieta absoluta.
- Sueroterapia. Según situación clínica del paciente, en pacientes adultos o con antecedentes de IRA o ICC sueroterapia con precaución.
- Vía venosa periférica.
- Analgesia y relajante muscular.
- Intento de reducción manual por parte del facultativo de Urgencias.
- Si la hernia es crural, no es posible la reducción o lleva más de 24 horas de encarcelación (sospecha de estrangulación), avisar al Servicio de Cirugía para valorar intervención quirúrgica urgente.

BIBLIOGRAFÍA

- Brooks DC. Classification, clinical features and diagnosis of inguinal and femoral hernias in adults. In: UpToDate [Internet]. Rosen M, Chen W (ed). Waltham, MA. [Accessed on October 2019]. Available in: www.uptodate.com.
- Brooks DC, Rosen M, Chen W. Overview of abdominal wall hernias in adults. In: UpToDate [Internet]. Hawn M, Rosen M, Chen W (ed). Waltham, MA. [Accessed on October 2019]. Available in: www.uptodate.com.
- Morales S, Barreiro F, Hernández P, Feliu X. Cirugía de la pared abdominal. 2ª ed. Guías Clínicas de la Asociación Española de Cirujanos. Madrid: Aran; 2013.
- <http://egresadosmedicinatijuana.blogspot.com/2009/12/hernia-umbilical-encarcelada.html>